

GENERALITES SUR L'ENDOSCOPIE DIGESTIVE

Dr BOUHOUCHE.H

Maitre assistant Hépatogastro-Entérologie

ENDOSCOPIE DIGESTIVE DIAGNOSTIQUE

ENDOSCOPIE DIGESTIVE THERAPEUTIQUE

A/ENDOSCOPIE DIGESTIVE DIAGNOSTIQUE :

1. FIBROSCOPIE OESO-GASTRO-DUODENALE
2. ENTEROSCOPIE
3. RECTOSCOPIE
4. COLOSCOPIE
5. VIDEOCAPSULE
6. CHROMOENDOSCOPIE (Chimique/électronique)
7. LATÉROSCOPIE
8. ECHOENDOSCOPIE

1-FIBROSCOPIE OESO-GASTRO-DUODENALE :

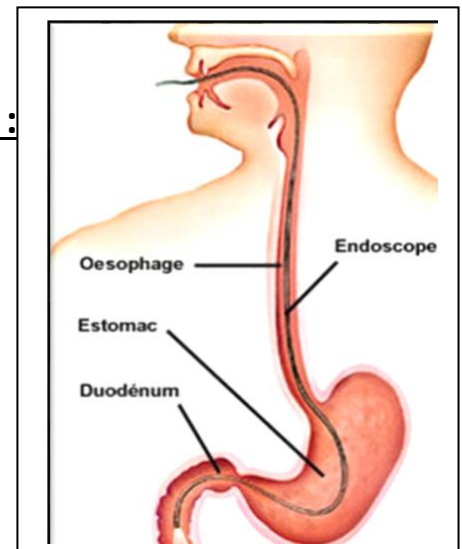
*** Définition :**

- Examiner directement le tube digestif supérieur : œsophage, estomac et duodénum.
- Faire différents prélèvements.
- D'effectuer divers traitements comme enlever un corps étranger ou un polype ou encore contrôler un saignement par électrocoagulation, etc.
- L'examen dure de 5 à 10 minutes.

***Matériel :**

Fibroscope

- Tube de 100 cm de longueur béquillage quadri-directionnel
- canal d'insufflation d'air
- canal pour lavage à l'eau
- canal opérateur : pour aspiration et introduire les instruments.





Fibroscope optique

***Indications :**

En urgence: HD, caustique , corps étranger...

- Douleurs épigastrique, dysphagie....
- Recherche les signes d'HTP
- Bilan étiologique d'une Anémie inexplicé...

***Contre-indications :**

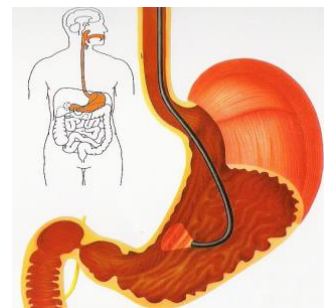
- Etat de choc.
- Insuffisance cardiaque ou respiratoire décompensée.
- Perforation digestive
- Troubles de conscience malade non intubé

***Déroulement de l'examen :**

- Estomac vide.
- Jeun de 6 heures.
- Ne pas fumer.
- Informé le médecin: * valvulopathie
* TRT anticoagulant
- Enlever ses prothèses dentaires
- DLG, tête légèrement fléchie.
- Anesthésie locale, AG

***RESULTATS :**

FOGD normale



Vidéo-endoscopie

FOGD pathologique



Varice œsophagienne



KC œsophage



Œsophagite peptique



Ulcère bulbaire



Kc gastrique



Kc duodénale

*Complications :

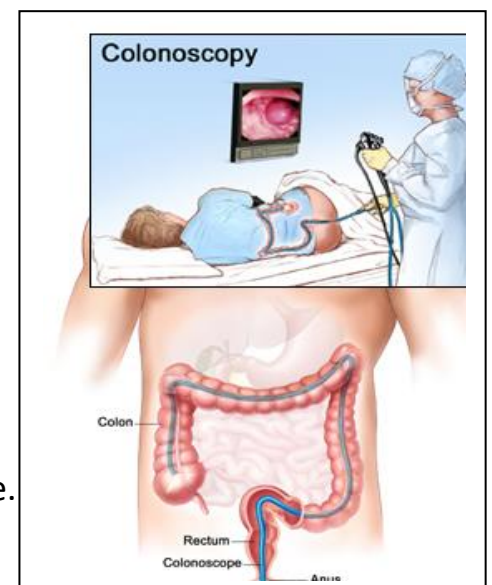
Exceptionnelles

- Pneumopathie d'inhalation
- Perforation
- Hémorragie
- Troubles cardio vasculaires et respiratoires
- Infection

2-COLOSCOPIE :

*Définition :

- Examiner directement le colon et la dernière anse iléale.
- Faire différents prélèvements.
- D'effectuer divers traitements comme enlever un polype ou encore contrôler un saignement par électrocoagulation, etc.



***Matériel :**

Coloscope :

Les mêmes caractéristiques que la FOGD, le diamètre et la longueur sont plus importantes (Tube de 140 - 160 cm de longueur)

***Indications :**

- Trouble de transit
- HD basse
- Douleurs abdominale, syndrome sub-occlusif...
- Dépistage de polypes et de CCR sujets à risques
- Anémie chroniques

***Contre-indications :**

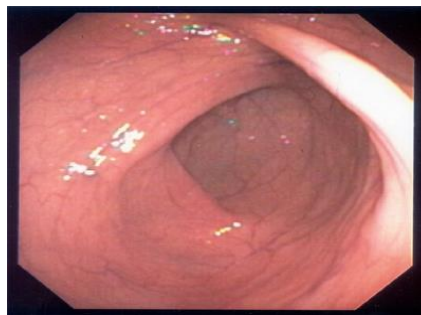
- Etat de choc.
- Insuffisance cardiaque ou respiratoire décompensée.
- Perforation digestive
- Occlusion, colectasie
- Diverticulite aigue

***Déroulement de l'examen :**

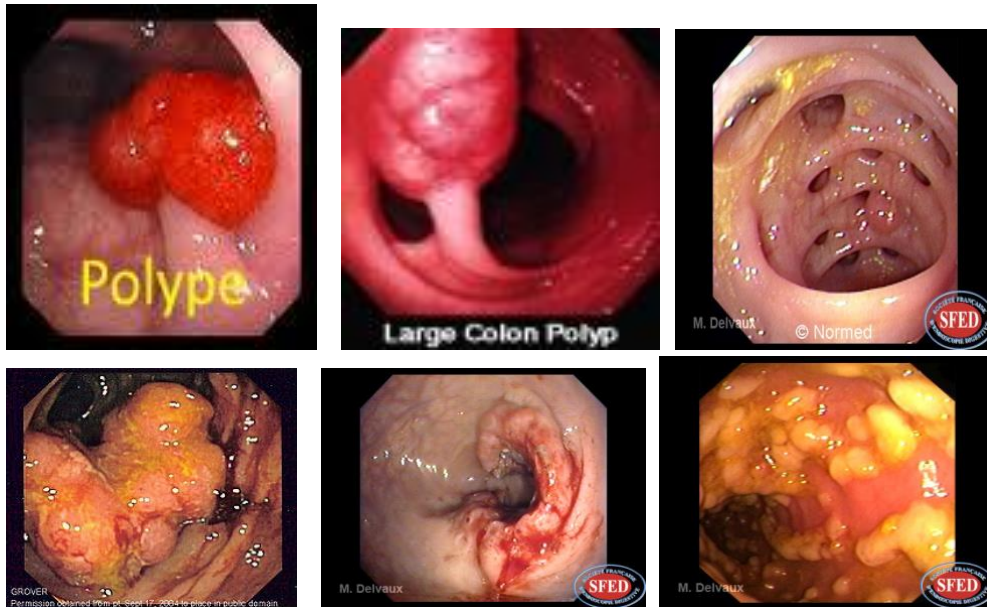
- Arrêt de médicament contenant du fer ou du charbon
- Régime sans résidus 4-5 jours avant
- Ingestion de 4 litres de PEG la veille
- Avec ou sans AG, examen +/- douloureux
- Examen sous contrôle de la vue, l'examen se fait au retrait

***RESULTATS**

Coloscopie normale



Coloscopie pathologique :



*Complications

Exceptionnelle :

- Perforation
- Hémorragie
- Troubles cardio vasculaires et respiratoires
- Occlusion lors de la préparation

3-RECTOSCOPIE :

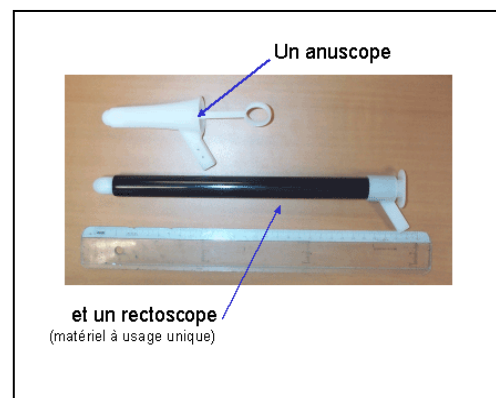
***Définition :** Exploration du rectum, +/- sigmoïde

***Matériel :**

- Un tube rigide contenant un système optique et lumineux
- 15-25 cm

***Indications :**

- Rectorragies
- Trouble du transit
- Proctalgies
- SD dysentérique
- Ecoulement anal....



***Déroulement de l'examen :**

- Préparation locale
- Position genu-pectorale
- Introduit par l'anus
- Une fois le rectoscope en place, de l'air est insufflé pour déplisser les parois du rectum et permettre une meilleure visualisation de la muqueuse
- Examen sous contrôle de la vue, l'examen se fait au retrait



4-AUTRES TECHNIQUES ENDOSCOPIQUES :

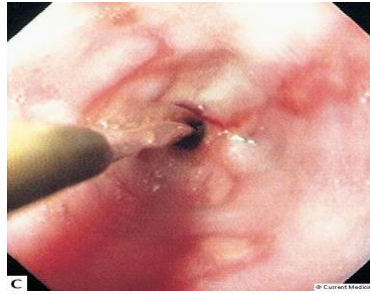
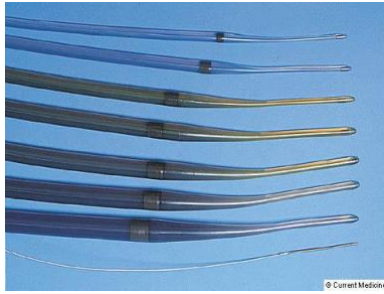
- Entéroscopie
- Vidéo-capsule
- Chromoendoscopie (Chimique/électronique)
- Latéroscopie
- Échoendoscopie

B/ENDOSCOPIE DIGESTIVE THERAPEUTIQUE :

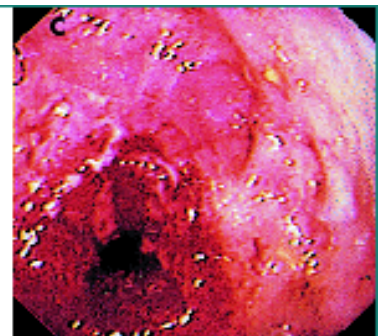
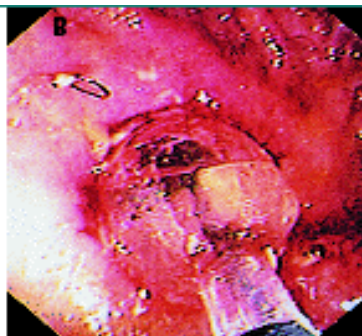
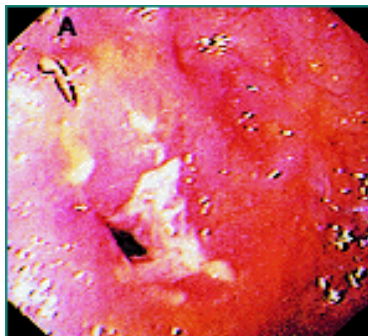
1. DILATATION ENDOSCOPIQUE
2. PROTHESES ENDOSCOPIQUE
3. EXCTRACTION DE CORPS ETRANGERS
4. POLYPECTOMIE ET MUCOSECTOMIE
5. HEMOSTASE ENDOSCOPIQUE
6. TRT INSTRUMENTAL DES HEMORROIDES
7. SPHINCTEROSCOPIE ENDOSCOPIQUE
8. GASTROSTOMIE ENDOSCOPIQUE PERCUTANE

1-DILATATION ENDOSCOPIQUE :

Dilater une sténose digestive accessible à l'endoscopie (œsophage , pylore ,colon ...)



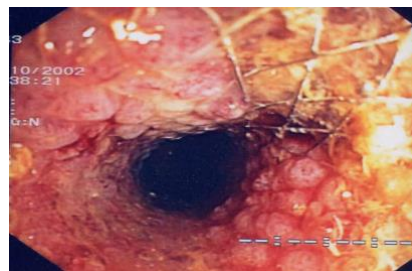
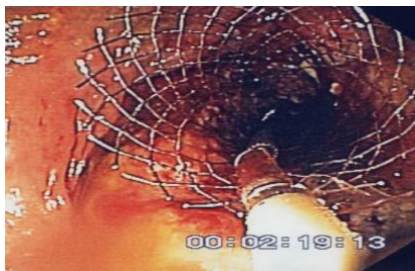
Dilatation par bougies



Dilatation par ballonnets

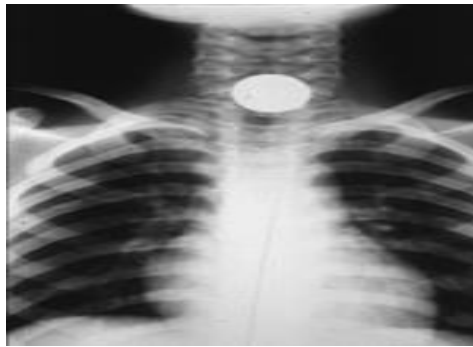
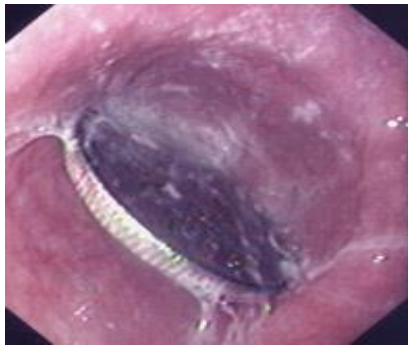
2-PROTHESES ENDOSCOPIQUE :

Traiter les sténoses digestives ou biliaires bénignes ou malignes



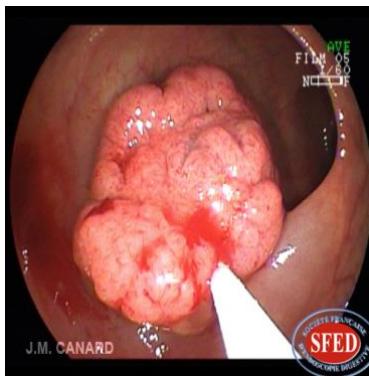
POSE DE PROTHESE COLIQUE

3-EXTRACTION DE CORPS ETRANGERS :



Corps étranger intra-oesophagien

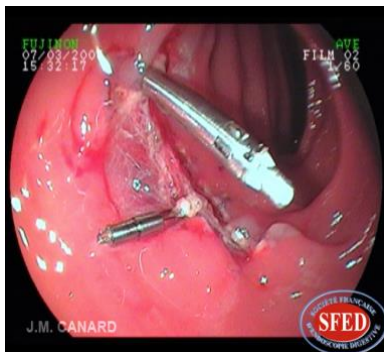
5-POLYPECTOMIE ET MUCOSECTOMIE :



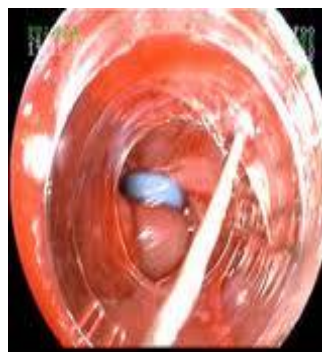
MUCOSECTOMIE :

- Exérèse complète des lésions planes ou sessiles de la muqueuse digestive
- Résection du plan sous-muqueux

6-HEMOSTASE ENDOSCOPIQUE :



POSE DE CLIPS HEMOSTATIQUES



Ligature élastique de VO

7-TRT INSTRUMENTAL DES HEMORROIDES :



TRT par infrarouge

TRT par ligature élastique

8-SPHINCTEROSCOPIE ENDOSCOPIQUE :

Cholangio-pancreatographie rétrograde endoscopique (CPRE)



CONCLUSION :

- Avancées +++ techniques endoscopiques
- Endoscopie thérapeutique: place de la chirurgie!!!